

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación

Ingeniería de Software I (SOFG1007) · Paralelo 1

PROYECTO DEL CURSO

CogniSync: Historias de Usuario

Versión 1 · borrador para validación con el cliente

Integrantes:

Andrade Domínguez Mateo Andrés

Fernández Ramos Juan Francisco

Morales Vásquez Víctor Manuel

Parrales Villacreses Diego Xavier

Saltos Preciado Andrés Alexander

Profesor: Dr. Carlos Mera Gómez

Cliente: Ing. Fabrizzio Ontaneda

PAO II 2026

1. Introducción

Este documento reúne las 23 historias de usuario de CogniSync, un sistema para clínicas de salud mental que reduce el trabajo administrativo de los terapeutas con notas clínicas estructuradas por IA y seguimiento de la evolución del paciente. Las historias salen del documento de requerimientos firmado por el cliente y de lo que falta en él para que el sistema funcione.

Cada historia usa el formato «Como <rol>, quiero <capacidad>, para <beneficio>» y se revisó con los criterios INVEST (independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y comprobable). Los requerimientos técnicos del cliente (React, FastAPI, PostgreSQL, Nginx, VPS) no se escribieron como historias porque describen el cómo y no aportan valor visible al usuario; quedan como restricciones de diseño. Los requerimientos de seguridad y usabilidad (UUID, HTTPS, diseño responsivo y registro en 3 minutos o menos) se aplican a todas las historias.

Los roles son dos: Terapeuta y Administrador de la clínica. Las historias se agrupan en seis épicas que siguen el flujo de trabajo del terapeuta.

Épica	Historias
E1. Acceso y roles	HU-01 a HU-04
E2. Expediente del paciente	HU-05 a HU-08
E3. Agenda y asistencia	HU-09 a HU-11
E4. Notas clínicas	HU-12 a HU-19
E5. Análisis y evolución	HU-20 a HU-22
E6. Cruce bibliográfico (futuro)	HU-23

2. Historias de usuario

E1. Acceso y roles

HU-01 Iniciar sesión

Como terapeuta, **quiero** iniciar sesión con mi correo y contraseña, **para** acceder solo yo a la información clínica de mis pacientes.

Justificación: Sale del requerimiento de autenticación segura. Es la base de todas las demás historias. No menciona JWT porque esa es una decisión técnica, no una necesidad del usuario.

HU-02 Cerrar sesión y expiración

Como terapeuta, **quiero** cerrar sesión y que mi sesión expire tras un tiempo sin uso, **para** que nadie vea expedientes si dejo el equipo abierto en el consultorio.

Justificación: No está escrita en el documento, pero forma parte de un inicio de sesión seguro cuando se manejan datos de salud mental. Se separó de HU-01 para que cada una se pruebe por su cuenta.

HU-03 Registrar terapeutas

Como administrador de la clínica, **quiero** registrar a los terapeutas de mi clínica, **para** que puedan usar el sistema con el rol correcto.

Justificación: Es el control de acceso por roles visto desde quien asigna los permisos. Sin ella, el rol de administrador no tendría ninguna función propia.

HU-04 Desactivar terapeutas

Como administrador de la clínica, **quiero** desactivar la cuenta de un terapeuta que deja la clínica, **para** que ya no pueda ver expedientes.

Justificación: Protege los datos cuando cambia el personal. Se separó de HU-03 para mantener las historias pequeñas.

E2. Expediente del paciente

HU-05 Crear expediente

Como terapeuta, **quiero** crear el expediente de un paciente nuevo con sus datos demográficos y antecedentes de consulta, **para** tener toda su información en un solo lugar desde la primera sesión.

Justificación: Corresponde al «crear» del expediente digital. Los campos exactos se validarán con el cliente porque el documento solo dice «demografía básica».

HU-06 Listar y buscar pacientes

Como terapeuta, **quiero** ver la lista de mis pacientes y buscarlos por nombre, **para** abrir rápido el expediente correcto antes o después de una sesión.

Justificación: Corresponde al «leer» del expediente. Plantea si cada terapeuta ve solo a sus pacientes, algo que el documento no define.

HU-07 Editar expediente

Como terapeuta, **quiero** actualizar los datos de un paciente, **para** que el expediente refleje su situación actual.

Justificación: Corresponde al «actualizar» del expediente. Es pequeña e independiente una vez que existe el paciente.

HU-08 Archivar paciente

Como terapeuta, **quiero** archivar a un paciente que terminó o abandonó el proceso, **para** mantener limpia mi lista sin perder su historial clínico.

Justificación: El cliente pidió «archivar», no «eliminar». En una historia clínica borrar datos no es adecuado, así que se respeta esa palabra.

E3. Agenda y asistencia

HU-09 Registrar citas

Como terapeuta, **quiero** registrar las citas de cada paciente con fecha y hora, **para** llevar el control de su asistencia.

Justificación: El módulo se llama «Pacientes y Agenda», pero no tiene ningún requerimiento de agenda. La alerta de deserción necesita el historial de citas, así que esta historia cubre esa omisión.

HU-10 Marcar asistencia

Como terapeuta, **quiero** marcar cada cita como asistida, cancelada o inasistencia, **para** que el sistema tenga el historial que necesita para detectar el riesgo de abandono.

Justificación: Separa el registro del dato de su análisis. Así HU-11 depende solo de este registro y no de toda la agenda.

HU-11 Alerta de deserción

Como terapeuta, **quiero** ver una alerta en mi panel cuando un paciente tiene alto riesgo de abandonar la terapia, **para** contactarlo a tiempo.

Justificación: Sale del requerimiento de alerta de deserción. «Alto riesgo» es ambiguo; se propondrá al cliente una regla medible, por ejemplo dos faltas seguidas o 40 % de citas perdidas en 60 días.

E4. Notas clínicas

HU-12 Nota por texto

Como terapeuta, **quiero** escribir un resumen rápido de la sesión en texto libre, **para** registrar lo ocurrido sin perder tiempo.

Justificación: Es la primera de las vías de captura y la más simple. Aquí se mide el límite de 3 minutos por paciente que pide el cliente.

HU-13 Nota por voz

Como terapeuta, **quiero** dictar la nota con mi voz y que se transcriba a texto, **para** registrar la sesión sin teclear.

Justificación: Segunda vía de captura. Se separó por vía porque cada una tiene un esfuerzo y un riesgo técnico distinto.

HU-14 Nota desde foto de apuntes

Como terapeuta, **quiero** subir una foto de mis apuntes en papel y obtener el texto, **para** no tener que transcribir a mano lo que escribí en la libreta.

Justificación: Tercera vía de captura. Es la de mayor riesgo, porque leer letra manuscrita es poco fiable, por eso no entra en el primer sprint.

HU-15 Estructurar en SOAP

Como terapeuta, **quiero** que el sistema convierta mis apuntes en una nota con formato SOAP, **para** tener una nota clínica estandarizada sin redactarla yo.

Justificación: Es el núcleo del producto: la estructuración automática con IA. Se separó del formato DAP para que el cliente pueda priorizar uno de los dos.

HU-16 Estructurar en DAP

Como terapeuta, **quiero** que el sistema convierta mis apuntes en una nota con formato DAP, **para** usar el formato que prefiero o que pide mi clínica.

Justificación: Mismo requerimiento que HU-15. Dividir por formato mantiene ambas historias pequeñas.

HU-17 Revisar la nota generada

Como terapeuta, **quiero** revisar y editar la nota que generó la IA antes de guardarla, **para** asegurarme de que no tenga errores, porque yo respondo por su contenido.

Justificación: Es una propuesta del equipo. La IA puede equivocarse y una nota clínica tiene peso legal y ético, así que el profesional debe aprobarla. Se validará con el cliente.

HU-18 Resumen de la sesión anterior

Como terapeuta, **quiero** ver un breve resumen de la sesión anterior al empezar una nueva nota, **para** retomar el hilo sin releer todo el expediente.

Justificación: Sale del requerimiento de memoria de contexto. «Breve» es ambiguo; se propondrá un máximo de cinco líneas.

HU-19 Historial de notas

Como terapeuta, **quiero** ver todas las notas de un paciente ordenadas por fecha, **para** revisar su proceso completo.

Justificación: El documento basa el análisis en las notas, pero nunca dice que se puedan consultar las anteriores. Esta historia cubre esa omisión.

E5. Análisis y evolución

HU-20 Etiquetar síntomas

Como terapeuta, **quiero** que el sistema detecte y etiquete los síntomas mencionados en cada nota, **para** no tener que clasificarlos yo.

Justificación: Sale del requerimiento de extracción de síntomas. Falta definir con el cliente cómo se mide la intensidad, que las gráficas necesitan.

HU-21 Corregir etiquetas

Como terapeuta, **quiero** agregar, quitar o corregir las etiquetas que puso la IA, **para** que las gráficas de evolución se basen en datos correctos.

Justificación: Propuesta del equipo, con la misma razón que HU-17: el profesional valida lo que hace la IA.

HU-22 Gráfica de evolución

Como terapeuta, **quiero** ver una gráfica de la intensidad y frecuencia de los síntomas de un paciente a lo largo del tiempo, **para** evaluar si está mejorando.

Justificación: Sale del requerimiento de mapas de calor longitudinales. Depende de HU-20, por eso va al final.

E6. Cruce bibliográfico (futuro)

HU-23 Sugerencias según manuales

Como terapeuta, **quiero** cruzar los síntomas del paciente con manuales terapéuticos, **para** recibir sugerencias de plan de intervención.

Justificación: El cliente la marca como futura. Se deja como historia grande, sin detalle, hasta confirmar si entra en el alcance del proyecto.

3. Referencias

[1] F. Ontaneda, «CogniSync: Requerimientos», documento del cliente firmado electrónicamente, 2026.

[2] C. Mera-Gómez y M. Villavicencio, «Requirements Elicitation and Documentation», diapositivas de Ingeniería de Software I, Unidad 4, ESPOL, 2026.

[3] IEEE Computer Society, SWEBOK Guide v4.0, cap. 1 «Software Requirements», 2024.

[4] K. S. Rubin, Essential Scrum, cap. 5 «Requirements and User Stories», Addison-Wesley, 2012.